形象化服药时间卡在野战条件情景下的应用

郎 瑜[1],游建平[2],白 杨[3],晏 玲[1*]
(1. 陆军军医大学第一附属医院儿科,重庆 400038; 2. 陆军军医大学第一附属医院全军感染病研究所,重庆 400038; 3. 陆军军医大学第一附属医院耳鼻喉科,重庆 400038)

[摘 要] 目的 探究形象化服药时间卡在野战条件语言沟通障碍情境下,对伤病员服药准确性的影响。方法 将"联合救援-2016"中-德卫勤实兵联合演练中 46 名有语言沟通障碍的"门诊伤病员",随机分为观察组和对照组,其中观察组与对照组各 23 人。观察组使用新设计制作的服药时间卡,并加之手势和面部表情传递服药时间及服药次数的信息;对照组仅使用手势及面部表情传递服药时间及服药次数的信息。结果 观察组"伤病员"对于服药时间及服药次数信息的正确掌握程度明显高于对照组($P<0.05$)。结论 野战条件语言沟通障碍情景下形象化服药时间卡的应用,可显著提高伤病员对服药时间及次数信息的掌握程度。

[关键词] 语言沟通障碍;服药时间卡;形象化
DOI: 10.16770/J.cnki.1008-9985.2018.03.013
[中图分类号] R 197.32 [文献标识码] A [文章编号] 1008-9985(2018)03-0241-03

Application of Picturesque Medication Time Card in the Context of Field Operation

LANG Yu[1], YOU Jianping[2], BAI Yang[3], YAN Ling[1*] (1. Department of Pediatrics, First Affiliated Hospital of Army Medical University, Chongqing 400038; 2. Military Institute of Infectious Diseases, First Affiliated Hospital of Army Medical University, Chongqing 400038; 3. Department of Otorhinolaryngology, First Affiliated Hospital of Army Medical University, Chongqing 400038)

[Abstract] **Objective** To explore the effect of picturesque medication time card on the accuracy of the wounded's medication in the context of language communication barriers in the field operation environment. **Methods** A total of 46 out-patients with language communication barriers inn the "Joint Rescue-2016" CHN-DEU Medical LIVEX were randomly divided into the observation group and the control group, with 23 in each group. With the observation group, the newly designed medication time card was used, along with gestures and facial expressions, to communicate information about medication time and frequency; with the control group, only gestures and facial expressions were used to communicate the information. **Results** The wounded in the observation group had a significantly better understanding of the information about medication time and frequency than the control group ($P<0.05$). **Conclusion** The application of picturesque medication time card in the context of language communication barriers in the field operation environment could dramatically improve the wounded's understanding of medication time and frequency.

[Key words] language communication barriers; medication time card; picturesque
Hosp Admin J Chin PLA, 2018, 25(3): 241-243.

随着中国综合国力不断上升,我军跨地域跨国界的野战医疗任务也不断增加。在野战医疗条件下,偏远地区语言沟通障碍是不可避免的问题。尤其是在野战医疗所的门诊,无法像病房一样做到随时服药到口,即使门诊现场将患者每日每次的口服药进行分袋包装交给患者,以减少服药剂量上的错误,但在语言沟通障碍的情况下,对于何时服药仅依靠肢体语言、面部表情进行交流很容易造成伤病员的误读,从而导致治疗效果不佳,甚至发生不良反应。既往研究[1-5]认为,形象化的图文对于健康宣教有着非常显著的效果,但通过文献检索及网络查找后发现,现今尚未有机构制作用于提高语言沟通障碍的伤病员服药时间准确性的形象化宣教资料,而这部分的空缺不仅是对语言沟通障碍伤病员人文关怀的缺失,更有甚者会因为错误服药时间导致药物治疗效果不佳,甚至导致不良反应的发生。所以在这次卫勤任务中,致力于提高有语言沟通障碍人群对服药时间及服药次数信息的正确掌握程度,设计制作形象化服药时间卡。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将此次"联合救援-2016"中-德卫勤

[作者简介] 郎 瑜,女,护士;电话:023-68765914
[通信作者] 晏 玲,E-mail: yanwen2099@126.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实兵联合演练中 46 名有语言沟通障碍的“门诊伤病员”，按就诊顺序分为两组，奇数为对照组，偶数为观察组，各 23 例。两组“门诊伤病员”均由第三军医大学 18～20 周岁的大一学员扮演，其中男 25 名、女 21 名，在演练过程中被设定为仅会听说本地语言的当地村民。对性别资料使用卡方检验，对年龄资料采用两独立样本的 t 检验，使用 SPSS 20.0 分析，结果表明，观察组和对照组在年龄、性别上的差异无统计学意义($P>0.05$)(表 1)。

表 1　两组“伤病员”年龄、性别的比较

变　量	观察组 ($n=23$)	对照组 ($n=23$)	P 值
年龄，(均值 ± 标准差)	19.26 ± 0.62	19.22 ± 0.60	0.375
性别，(男/女)	14/9	11/12	0.810

1.2　方法　在导演组及门诊工作人员均对此次实验不知情的情况下，导演组将 46 名有语言沟通障碍的“伤病员”安排至门诊就诊，研究人员将 23 张形象化服药卡片交给门诊工作人员，并交代用于偶数顺序就诊的 23 名有语言沟通障碍的“伤病员”(观察组)，在卡片上直接进行打勾或者画圈，加之手势、面部表情向“伤病员”传递服药时间及服药次数的信息；在其余有语言沟通障碍的“伤病员”(对照组)就诊时，门诊工作人员使用手势及面部表情传递服药时间及服药次数的信息。门诊每名伤病员的姓名、诊断、主诉、查体结果、药品发放数量、服药频次及时间均登记在门诊患者病历及门诊患者登记本内。

1.2.1　制作形象化服药卡片　根据此次任务中野战医疗所门诊所申领、携带药物的用药常规，广泛查阅文献，征询医疗队中各专家教授意见。设计制作大小为 9.5×9.5 cm 的硬质卡片，内容上使用形象化的图谱直观生动地表达每日用药时间及频次，形象化服药卡片(图 1)。

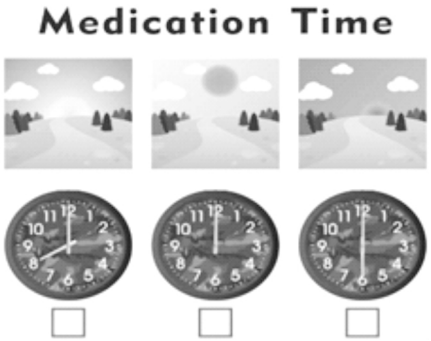

图 1　形象化服药时间卡

1.2.2　问卷调查　在当日门诊工作结束后，由研究人员召集演练中 46 名有语言沟通障碍的“门诊伤病员”集中进行调查问卷及简短随访。调查问卷以问题通俗无暗示性、答案简单明确为原则，包括指导语、基本情况和主要条目三个部分，主要条目具体(表 2)。

表 2　伤病员对形象化服药卡使用情况的调查问卷

条　目
1. 每日服药时间:
2. 每日服药次数:
3. 卡片图片是否易于理解:
4. 卡片信息是否易于记忆:
5. 对该卡片的改进意见:

1.3　判断标准　使用每日门诊病历与调查问卷相对照，在问卷调查中前两项均正确视为完全正确掌握；前两项中有一项错误视为部分正确掌握；前两项均错误则视为完全未掌握。

1.4　统计学方法　计数资料采用 χ^2 检验，使用 SPSS 20.0 分析，以 $P<0.05$ 认为差异有统计学意义。

2　结　果

表 3、图 2 可见，观察组和对照组的“伤病员”对服药时间及服药次数的信息(服药时间和服药频率)的掌握程度具有显著的统计学差异，其中观察组“伤病员”对服药时间及服药次数的信息完全掌握正确的占观察组总人数的 91.3%，而对照组这一比例为 21.7%；观察组对服药时间及服药次数的信息部分掌握正确的人数占 8.7%，对照组为 43.5%；更为突出的是，观察组对服药时间及服药次数的信息完全未掌握的人数为 0，而对照组中有 34.8% 的“伤病员”对服药时间及服药次数的信息完全未掌握。

表 3　两组“伤病员”对服药准确性的掌握程度比较 [n(%)]

变　量	对照组 ($n=23$)	观察组 ($n=23$)	χ^2	P 值
完全正确掌握	5(21.7)	21 (91.3)	22.65	<0.05
部分正确掌握	10(43.5)	2(8.7)	7.22	<0.05
完全未掌握	8(34.8)	0(0)	9.68	<0.05

3　讨　论

从以往的健康教育工作经验中得知，图文式的健康教育手册吸引力更佳，互动性更强[6]，能更好地体现对患者的人文关怀。在面对语言沟通障碍人群时，将图形创意通过转化成为信息传达的视觉符号在传播材料中的运用变得尤为重要[7]。同一种药物在同剂量下，给药时间不同，药物对机体效果及毒副作用均会有所不同，甚至有很大差异，因此，正确的用药时间及服药次数在患者康复的过程中有重要的作用。

在 Kauppi K 等的系统评价中也提到，信息提示可能有助于提高患者正确服药几率[8]，这虽然可以为形象化服药时间卡的广泛推广使用提供一定的科学依

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

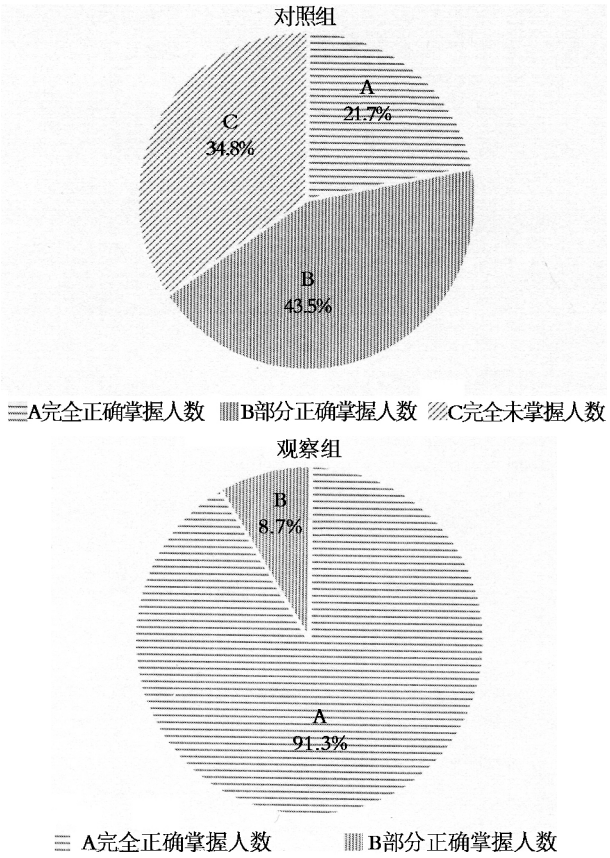

图 2 两组“伤病员”对服药准确性掌握情况的构成比

据，但却无法在野战条件下进行推广使用，因为在野战条件下，患者的通信很难得到完全保证，即使得到保证，在语言不通的条件下，通信干预这一方法也是难以实现的，因此在此系统评价的理论基础上设计制作形象化服药卡，使用纸质图像化信息进行干预并且在上述随机对照实验中取得良好的效果。这是因为形象化服药卡被制作成大小为 9.5×9.5 cm 的硬质卡片，这种大小的卡纸便于随身携带，易于伤病员及其家属掌握医护人员在形象化的图片上勾画服药时间及服药次数的信息，提高伤病员对服药时间及服药次数信息的正确掌握程度，从而降低由于跨语言交流造成的信息误读，有助于伤病员正确掌握服药时间及服药次数的信息。在此次“联合救援－2016”中－德卫勤实兵联合演练中，形象化服药时间卡完全使用生动直接的图片符号进行有效信息的传递，提高门诊医护人员在服药时间及服药次数信息的宣教效率，得到“伤病员”的一致好评及医护人员的肯定，为语言沟通障碍人群的健康恢复提供有力保障。

在查阅文献证据时也发现 Nieuwlaat R 等[9]的证据表明关于服药的健康问题大多是复杂的，且各种干预措施不是很有效，无法使治疗效果充分实现。后期对学员的访谈中也有一位学员表示，“这种服药卡片虽然可以让我在比比划划中就知道我每天该什么时候吃药，但是即使我心里知道每天该什么时候吃药，吃几次，也并不能保证自己会按时吃药，因为总有这样或者那样的原因让自己无法按时吃药。”虽然形象化服药时间卡[3-4]在应用过程中，确实可以保障在语言沟通障碍时服药时间信息的正确传递，但是要完全提高伤病员服药的正确性，仍需在各方面进行改进；如长期干预措施，这需要足够的研究能力及样本量，检测改进措施对提高伤病员服药时间及服药次数正确掌握程度的应用效果。

此次随机对照试验验证形象化服药时间卡在语言沟通障碍情境下，提高有语言沟通障碍人群对服药时间及服药次数信息的正确掌握程度。但是此次随机对照试验中的医护人员和“伤病员”之间有共同的文化背景，且“伤病员”文化层次较高，这对实验结果会有一定正性的影响，这一点是不容忽视的[5-6]。

4 小 结

在此次“联合救援－2016”中－德卫勤实兵联合演练中，设计制作的形象化服药时间卡制作简单，内容生动直接，易掌握、记忆，能提高在语言沟通障碍时的宣教效率，提高伤病员掌握服药时间及服药次数，一定程度上保证药物治疗的效果，预防药物不良反应的发生，利于伤病员健康恢复，值得在有语言交流障碍的人群中推广及应用。但应用的同时，也需要其他干预措施的辅助以达到最佳治疗效果。

【参考文献】

[1] 陈洁. 形象化健康教育对老年慢性阻塞性肺病患者呼吸功能锻炼的影响[J]. 现代实用医学，2016，28(2)：271－272.
[2] 陈叶俊，余红，李悦. 儿童形象化口腔健康教育模式的应用效果观察[J]. 中国卫生标准管理，2015，12(9)：11－12.
[3] 朱三玲，樊启财，左云海. 形象化健康教育对高血压患者生活方式和服药依从性的影响[J]. 中国当代医药，2015，22(12)：155－157.
[4] 孙晓蓓，王巧桂. 图文式健康教育对老年股骨粗隆间骨折患者术后功能恢复的影响[J]. 中华现代护理杂志，2015，21(22)：2642－2644.
[5] 周琦，张蕾，王晓凤. 多语图文卡片在维吾尔族耳部疾病患者及气管切开术后不能言语患者健康教育中的效果分析[J]. 新疆医学，2015，45(10)：1541－1544.
[6] 邵海波，陈凌，王晶等. 图文式健康教育在胃镜检查患者中的应用[J]. 上海护理，2016，16(4)：63－64.
[7] 彭尧. 人文关怀在健康传播材料设计中的应用[J]. 健康教育与健康促进，2012，7(3)：225－227.
[8] Kauppi K，Välimäki M，Hätönen HM and so on. Information and communication technology based prompting for treatment compliance for people with serious mental illness[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews，2014，Issue 6. Art. No.：CD009960.
[9] Nieuwlaat R，Wilczynski N，Navarro Tand so on. Ways to help people follow prescribed medicines[J]. Copyright 2014 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons，Ltd. 20 November 2014.

(2017－12－01 收稿 2018－02－21 修回)
(本文编辑 胡友花)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net